

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

polaprezinc 75mg (프로맥과립, SK케미칼)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1포 중 polaprezinc 75mg

☐ 효능 효과 :

- 1. 위궤양
- 2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선:
급성위염, 만성위염의 급성 악화기

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2009년 제8차 약제급여평가위원회 : 2009년 8월 20일

2009년 제13차 약제급여평가위원회 : 2009년 12월 17일 (재평가)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2009년 제8차 약제급여평가위원회)

○ 비급여.

- 신청품은 “위궤양, 급성위염·만성위염의 급성악화기 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선”에 허가받은 약제로, 개발국 외 사용국가가 없고 교과서 및 임상지침 수재내역이 미비하며 관련 임상문헌이 검색되지 않는 등 상대적인 임상적 유용성이 불분명하고, 대체약제에 비하여 소요비용이 고가이므로 비급여함.

□ 최종결과(2009년 제13차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “위궤양, 급성위염·만성위염의 급성악화기 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선”에 허가받은 약제로, 위염에 대해서는 국내에서 실시한 허가임상을 통해 [REDACTED] 비열등함을 입증하였으며 통계적 가정이거나 평가변수 등이 명확히 제시되어 있고 소요비용이 대체약제의 가중일일투약비용 이하인 점 등을 고려시, 위염 적응증에 한하여 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “위궤양, 급성위염·만성위염의 급성악화기의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일하거나 유사한 적응증에 허가받은 rebamipide 등 다수의 제품이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 zinc와 L-carnosine의 착화합물로 소화성궤양의 치료에 사용되는 cytoprotective drugs로 분류됨.¹⁾
- 1994년 일본에서 위궤양에 허가된 이후 더이상의 사용 국가 없으며, Martindale 외 교과서나 임상지침 수재내역은 확인 불가함.
- 신청품의 허가 적응증 관련 임상문헌은 검색되지 않았으며²⁾, 제약사 제출 문헌 중 일본 문헌은 통계적 가정이거나 1차 유효성 평가변수 등이 불분명함.
 - 내시경상 A1, A2단계의 활동기로 진단된 단발성 위궤양환자 299명을 대상으로 이중맹검, 무작위배정, cetraxate대조 임상시험을 수행한 결과 8주후 최종 전반적개선도 등에서 통계적 유의차를 보이지 않음.³⁾⁴⁾

- 내시경에 의해 미란이나 출혈을 동반하는 위염으로 진단된 환자 348명을 대상으로 이중맹검, 무작위배정, sucralfate대조 임상시험을 수행한 결과, 2주후 전반개선도 등이 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않음($p=0.3095$).⁵⁾⁶⁾

- 국내에서 실시한 급성위염·만성위염 [REDACTED] 환자 [REDACTED] 대상으로 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] 임상시험 결과, [REDACTED] 비열등함.⁷⁾

○ 비용 효과성

- 교과서와 임상지침⁸⁾⁹⁾ 등에서 cytoprotective drugs로 분류된 약제들이, 허가사항을 바탕으로 위염과 위궤양에 구분되어 청구 및 심사가 이루어지고 있는 점 등을 고려하여 위염 및 위궤양에 각각의 대체약제를 선정.
- 위궤양의 대체약제는 rebamipide, teprenone, ecabet sodium이며, 위염의 대체약제는 rebamipide, artemisia asiatica 95% ethanol ext., teprenone임¹⁰⁾.
- 위염 및 위궤양의 대체약제 가중일일투약비용은 [REDACTED]원으로, 신청품의 일일투약비용([REDACTED]원)이 저가로 검토됨.
 - 위궤양의 대체약제 가중일일투약비용은 [REDACTED]원으로, 신청품의 일일투약비용([REDACTED]원)이 고가임.
 - 위염의 대체약제 가중일일투약비용은 [REDACTED]원으로, 신청품의 일일투약비용([REDACTED]원)이 저가임.

○ 재정 영향

- 위궤양·위염에 급여시, 신청품 투여 대상 환자수¹¹⁾는 1차년도 약 [REDACTED]명에서 3차년도 약 [REDACTED]명으로 증가할 것으로 예상되며 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고, 위궤양 및 위염에서 대체약제를 대체하여 발생하는 재정절감액은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원으로 증가할 것으로 예상됨.¹³⁾¹⁴⁾
 - 위염에 국한하여 급여시, 신청품 투여 대상 환자수¹⁵⁾는 1차년도 약 [REDACTED]명에서 3차년도 약 [REDACTED]명으로 증가할 것으로 예상되며 신청품 도입 후 절대재정 소요금액¹⁶⁾은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고, 위염의 대체약제를 대체하여 발생하는 재정절감액은 1차년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원으로 증가할 것으로 예상됨.¹⁷⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본에 등재되어 있음.

REFERENCE

- 1) Martindale 35th ed.
- 2) 다만, EMBASE에서 Z-103으로 검색시 위염에 대한 sucralfate대조 임상 및 2상 임상 두편의 서지 정보가 검색됨.
- 3) 신청품의 위궤양에 대한 일본허가임상- 三好秋馬 et al, 위궤양에 대한 Z-103의 임상적 유용성 검토- 염산 세트락세이트를 대조약물로 사용한 다기관 이중맹검시험 Jpn Pharmacol Ther, 1992; 20(1): 199-223
- 4) 4주와 8주의 결과를 종합한 최종 판정에서 자타각 증상의 개선도 개선율(신청품군 85.0%, 대조군 80.6%, n.s.), 내시경상 치유율(신청품군 51.1%, 대조군 38.6%, $p<0.05$), 내시경상 유효율(신청품군 62.6%, 대조군 48.0%, $p<0.05$), 최종 전반적개선도 판정에서 “현저한 개선”의 개선율(신청품군 50.4%, 대조군 37.9%, $p<0.05$), “중등도 이상”의 개선율(신청품군 70.4%, 대조군 67.8%, n.s.)
- 5) 일본내 출간 문헌- Takeshi Miwa et al. 위염에 대한 Z-103의 다기관, 수크랄페이트 대조, 이중맹검 비교시험 Jpn Pharmacol Ther, 1997; 25(4): 325-366
- 6) 2주후 자타각 증상에 따른 전반개선도의 개선율(신청품군 81.2%, 대조군 78.4%, $p=0.9105$), 내시경상 전반개선도의 개선율(신청품군 75.5%, 대조군 71.3%, $p=0.4396$), 종합적 전반개선도의 개선율(신청품군 77.4%, 대조군 71.9%, $p=0.3095$), 신퇴구간 하한치 -10% 초과로 내시경상 전반개선도 및 전반개선도 동등
- 7) 신청품의 위염에 대한 국내허가임상으로 [REDACTED]
- 8) Martindale 35th ed.
- 9) 소화기관용제 권장지침. 대한의사협회, 2003년 4월
- 10) <신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준(2009.09)>
 - 대체약제 가중평균가 산출시 위원회 별도 심의 사항
 - 소량 청구품목이 다수 등재되어 있는 등 분석의 어려움이 있는 경우에 사용량 등을 고려.
 - 산출된 대체약제 가중평균가가 현저히 불합리하다고 판단되는 경우(대체약제 간 효과가 열등하나 비용이 고가인 약제가 포함된 가중평균가 등)
 - 위 기준 및 상위 3품목이 전체 청구량의 [REDACTED]% 이상을 차지하는 점 등을 고려하여 대체약제 선정.
- 11) 대상 환자수= 동계열 약제를 처방받은 위염·위궤양환자수^{주1}*신청품의 예상 대체환자 비율^{주2}
(주1. 2006~2008년 청구환자수 기준으로 추정 주2. 제약사는 발매 1년차 [REDACTED]%, 2년차 [REDACTED]%, 3년차 [REDACTED]%로 대체환자 비율을 가정)
- 12) 절대재정 소요금액= 대상 환자수*예상 투약일수(위염: 14일, 위궤양: 56일) * 신청품의 일일투약 비용
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 재정증감= (위궤양 대상 환자수*56일*(신청품의 일일투약비용-대체약제의 가중일일투약비용))+ (위염 대상 환자수*14일*(신청품의 일일투약비용-대체약제의 가중일일투약비용))
- 15) 대상 환자수= 동계열 약제를 처방받은 위염환자수^{주1}*신청품의 예상 대체환자 비율^{주2}
(주1. 2006~2008년 청구환자수 기준으로 추정 주2. 제약사는 발매 1년차 [REDACTED]%, 2년차 [REDACTED]%, 3년차 [REDACTED]%로 대체환자 비율을 가정)
- 16) 절대재정 소요금액= 대상 환자수*예상 투약일수(위염: 14일)*신청품의 일일투약비용
- 17) 재정증감=위염대상 환자수*14일*(신청품의 일일투약비용-대체약제의 가중일일투약비용)